

Adénomectomie prostatique

WARWIKI

Information pour le patient · Chirurgie pour une très grosse prostate (HBP)

L'adénomectomie prostatique (prostatectomie simple) est une chirurgie pour une **très grosse prostate atteinte d'hypertrophie bénigne (HBP)** qui bloque l'écoulement de l'urine. Le chirurgien retire la partie interne volumineuse de la prostate — celle qui cause l'obstruction — par voie abdominale, en chirurgie ouverte ou robotique/mini-invasive. Elle est très efficace pour les grosses glandes.

Une différence importante

La prostatectomie « simple » **n'est pas** la même chose que la prostatectomie « radicale » pratiquée pour le **cancer** de la prostate. L'opération radicale retire toute la prostate pour traiter un cancer. La prostatectomie **simple** ne retire que le tissu interne bénin élargi et laisse l'enveloppe externe en place — elle traite une **obstruction due à une augmentation de volume non cancéreuse**.

Quand est-elle indiquée ?

- Pour les **très grosses prostates** peu adaptées à une résection endoscopique standard (résection transurétrale, RTU)
- En particulier lorsqu'il existe aussi des **calculs vésicaux** ou de grands diverticules à traiter
- Des options endoscopiques pour les grosses glandes (**HoLEP, Aquablation**) existent également — votre chirurgien vous conseillera la technique la mieux adaptée

COMPRENDRE LES TERMES

Adénomectomie prostatique

Retrait de la partie interne élargie de la prostate pour l'HBP (pas pour un cancer).

Adénome

Le tissu prostatique interne bénin qui est retiré.

Prostatectomie radicale

Une opération différente qui retire toute la prostate pour traiter un cancer.

Ouverte ou robotique

Par une incision unique, ou par de petites incisions mini-invasives.

Éjaculation rétrograde

Orgasme sec — effet secondaire fréquent.

Sonde

Tube qui draine la vessie pendant plusieurs jours après l'opération.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'opération se déroule sous anesthésie générale, vous ne ressentez rien pendant l'acte. Comme il s'agit d'une chirurgie abdominale, la récupération est **plus longue qu'une procédure endoscopique** — prévoyez quelques jours d'hospitalisation (moins avec la chirurgie robotique), une sonde pendant plusieurs jours, et quelques semaines d'activité limitée.

Comment vous préparer

- Opération sous **anesthésie générale** — respectez les consignes de jeûne et de médicaments (arrêtez les anticoagulants selon les instructions).
- Une **analyse d'urine** sera réalisée pour exclure une infection.
- Ne fumez pas ; prévoyez un accompagnateur et de l'aide à domicile.

Déroulement & Après

- 1 Vous êtes endormi(e) ; des antibiotiques vous sont administrés.
- 2 Par voie abdominale ouverte ou robotique/mini-invasive, la partie interne volumineuse de la prostate est retirée ; l'enveloppe externe est laissée en place.
- 3 Une sonde (et parfois un drain) est posée ; l'hospitalisation dure quelques jours (moins avec la chirurgie robotique).
- 4 La sonde reste en place **plusieurs jours à environ une semaine**.

Des urines légèrement teintées de sang sont normales au début ; **évitez les efforts lourds et les poussées** pendant plusieurs semaines.

À quoi s'attendre après

- Une amélioration forte et durable du débit urinaire.
- L'**éjaculation rétrograde** (orgasme sec) est fréquente ; les effets sérieux sur l'érection ou la continence sont rares.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- **Impossibilité d'uriner** après le retrait de la sonde
- **Saignement abondant ou caillots**, ou de la fièvre/frissons
- Douleur abdominale croissante, ou rougeur/écoulement de la plaie
- Douleur thoracique, difficultés à respirer, ou jambe gonflée et douloureuse (urgence)

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'adénomectomie retire la partie interne volumineuse de la prostate pour une HBP très importante — ce **n'est pas** l'opération du cancer (qui retire toute la prostate).
2. Elle est très efficace pour les grosses glandes ; la récupération est plus longue qu'une procédure endoscopique (HoLEP/Aquablation sont des alternatives endoscopiques).
3. Prévoyez une éjaculation sèche et une sonde pendant plusieurs jours. Appelez en cas d'impossibilité d'uriner, de saignement abondant ou de fièvre.